

CAPÍTULO 14.14

Síndrome Antifosfolípido

PERFIL EUNACOM 1.01.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Antifosfolípido (SAF)** es una de las causas más importantes de **trombofilia adquirida**. A diferencia de las trombofilias congénitas (como el Factor V de Leiden o el déficit de Proteína C/S), el SAF se desarrolla a lo largo de la vida y tiene una base autoinmune caracterizada por un estado de hipercoagulabilidad tanto venosa como arterial.

Clasificación del SAF

Clínicamente, el SAF se divide en dos grandes categorías dependiendo de su asociación con otras patologías:

- **SAF Primario:** Se presenta de forma aislada, sin evidencia de otra enfermedad subyacente.
- **SAF Secundario:** Se asocia a otra enfermedad autoinmune sistémica. La asociación más relevante y frecuente para el EUNACOM es con el **Lupus Eritematoso Sistémico (LES)**.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante un paciente con diagnóstico de **Lupus Eritematoso Sistémico**, siempre se debe sospechar o tamizar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ya que esto cambia radicalmente el pronóstico y el tratamiento antitrombótico.

Manifestaciones Clínicas

El SAF se caracteriza por dos pilares clínicos fundamentales: los fenómenos trombóticos y las complicaciones obstétricas.

1. Fenómenos Trombóticos

A diferencia de otras trombofilias que son predominantemente venosas, el SAF puede afectar cualquier vaso sanguíneo:

- **Trombosis Venosas:** La más frecuente es la **Trombosis Venosa Profunda (TVP)** de extremidades inferiores y el **Embolia Pulmonar (TEP)**.
- **Trombosis Arteriales:** Son muy características de este síndrome. Pueden manifestarse como un **Accidente Cerebrovascular (AVE)** isquémico o ataques isquémicos transitorios (TIA) en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular tradicionales.

2. Complicaciones Obstétricas

El SAF es una causa tratable de morbilidad en el embarazo. Los criterios clínicos incluyen:

- **Abortos espontáneos:** Pueden ser eventos únicos (después de la semana 10 con feto morfológicamente normal) o múltiples abortos

2. Prolongación del TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada):

recurrentes (3 o más antes de la semana 10).

- **Partos prematuros:** Nacimientos antes de la semana 34 debido a insuficiencia placentaria grave o eclampsia.
- **Preeclampsia:** El SAF es un factor de riesgo crítico para el desarrollo de **Preeclampsia** grave y otras formas de microangiopatía placentaria.

TABLA 14.14.1: TIPO DE EVENTO VS EJEMPLOS COMUNES

TIPO DE EVENTO	EJEMPLOS COMUNES
Trombosis Venosa	TVP, TEP, Trombosis de senos venosos cerebrales.
Trombosis Arterial	AVE isquémico, Infarto agudo al miocardio, Isquemia de extremidades.
Obstétrico	Pérdida fetal >10 sem, 3+ abortos <10 sem, Parto prematuro <34 sem.

Marcadores de Laboratorio y Diagnóstico

El diagnóstico de SAF no puede hacerse solo con exámenes de sangre ni solo con la clínica; requiere la combinación de ambos (**Criterio Clínico + Criterio de Laboratorio**).

Anticuerpos Específicos

- **Anticardiolipinas (IgG o IgM).** - **Anti-beta2-glicoproteína I.** - **Anticoagulante lúpico.**

Hallazgos de Laboratorio "Atípicos" (Perlas de examen)

Existen dos hallazgos que suelen aparecer en las preguntas de examen y que pueden confundir al clínico:

- **VDRL Falsamente Positivo:** El reactivo del VDRL utiliza cardiolipina. Por lo tanto, los anticuerpos del paciente con SAF pueden reaccionar con la prueba, dando un resultado positivo para sífilis sin que el paciente tenga la infección.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Antes de diagnosticar SAF por un VDRL positivo, se debe realizar una **prueba treponémica específica** (como el FTA-ABS). Si la prueba treponémica es negativa pero el VDRL es positivo, estamos ante un marcador sugerente de SAF.

NOTA CLÍNICA

Es paradójico que una enfermedad que produce trombosis (coágulos) alargue un tiempo de coagulación (que normalmente sugiere sangrado). Esto ocurre porque los reactivos del examen de TTPA contienen fosfolípidos que son "bloqueados" in vitro por el anticoagulante lúpico, retrasando la formación del coágulo en el tubo de ensayo, aunque in vivo el paciente esté en un estado protrombótico.

Diagnóstico Confirmatorio

- Para confirmar el síndrome, se exige:
- **Al menos 1 criterio clínico** (trombosis documentada o complicación obstétrica definida).
- **Al menos 1 criterio de laboratorio** positivo en dos o más ocasiones, separadas por al menos 12 semanas.

EUNACOM CRITERIOS

Si un paciente tiene los anticuerpos positivos pero nunca ha tenido un evento trombótico ni obstétrico, **no tiene Síndrome Antifosfolípido**, sino únicamente "portación de anticuerpos antifosfolípidos". El diagnóstico requiere la clínica.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento depende del escenario clínico del paciente.

1. Paciente con SAF y evento trombótico previo

El pilar es la anticoagulación crónica. - Se utiliza una combinación de **Anticoagulación Oral (TACO) + Aspirina (AAS)**. - **Elección del anticoagulante:** Se prefieren los **cumarínicos** (como el Acenocumarol o la Warfarina). -

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

A diferencia de otras patologías, en el SAF (especialmente el de alto riesgo o triple positivo), los nuevos anticoagulantes orales de acción directa (DOACs como Rivaroxaban o Apixaban) han mostrado ser **inferiores** a los cumarínicos y no se recomiendan de primera línea.

2. Manejo en el Embarazo

Los cumarínicos son teratogénicos y están contraindicados en el embarazo. - Se debe cambiar a **Heparina de Bajo Peso Molecular (HBPM)** en dosis profilácticas o terapéuticas según el riesgo. - Se asocia habitualmente con Aspirina en dosis bajas.

3. Paciente con anticuerpos positivos pero SIN clínica

- **Conducta general:** No se anticoagula. Se realiza observación y control de otros factores de riesgo cardiovascular. - **En el embarazo:** Si una mujer tiene anticuerpos positivos pero no cumple criterios de SAF (nunca ha tenido abortos ni trombosis), se suele dejar **Aspirina** o dosis profilácticas de heparina para prevenir complicaciones como la **Preeclampsia**, pero no se considera tratamiento del síndrome propiamente tal.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Resumen terapéutico: 1. SAF con trombosis: TACO (Cumarínicos) de por vida. 2. SAF en embarazo: Heparina de bajo peso molecular + Aspirina. 3. Anticuerpos (+) sin clínica: No tratar (excepto profilaxis obstétrica específica).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con SAF confirmado requiere anticoagulación. ¿Cuál es el anticoagulante oral de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndrome Antifosfolípido. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SAF: trombofilia adquirida, primario o secundario (principalmente a lupus)
- Clínica: fenómenos trombóticos (TVP, TEP, ACV) + complicaciones obstétricas (abortos, prematuridad, preeclampsia)
- Marcadores: anticuerpos antifosfolípidos, anticardiolipinas, VDRL falso positivo, TTPA alargado
- Diagnóstico requiere clínica + marcadores; sin clínica no hay SAF
- Tratamiento: TACO con cumarínicos (no NACO) + aspirina; en embarazo HBPM
- Solo anticuerpos sin clínica = no tratar

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO)

PREGUNTA 1

Paciente con SAF confirmado requiere anticoagulación. ¿Cuál es el anticoagulante oral de elección?

- A) Rivaroxabán
- B) Apixabán
- C) Acenocumarol o warfarina
- D) Dabigatrán
- E) Edoxabán

PREGUNTA 2

Paciente con anticuerpos antifosfolípidos positivos pero sin ningún evento trombótico ni obstétrico. ¿Cuál es la conducta?

- A) Iniciar anticoagulación con cumarínicos
- B) Iniciar aspirina profiláctica
- C) No hacer nada, el SAF solo se trata con clínica
- D) Iniciar heparina de bajo peso molecular
- E) Solicitar biopsia para confirmar diagnóstico

PREGUNTA 3

¿Por qué el TTPA puede estar alargado en el SAF si es una trombofilia?

- A) Por consumo de factores de coagulación
- B) Por los anticuerpos antifosfolípidos que interfieren con los fosfolípidos del reactivo
- C) Por deficiencia de vitamina K
- D) Por uso concomitante de heparina
- E) Por trombocitopenia severa

RESUMEN: SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una trombofilia adquirida que puede ser primario o secundario (principalmente a lupus). Se manifiesta con fenómenos trombóticos (TVP, TEP, ACV, trombosis arteriales) y complicaciones obstétricas (abortos, partos prematuros, preeclampsia). Los marcadores incluyen anticuerpos antifosfolípidos y anticardiolipinas, VDRL falsamente positivo (descartar sífilis) y TTPA alargado (paradójico: trombofilia con TTPA alargado por interferencia con fosfolípidos del reactivo). El diagnóstico requiere clínica + marcadores; sin clínica no hay SAF aunque tenga anticuerpos. El tratamiento es anticoagulación oral con cumarínicos (no NACO/DACO) más aspirina. En embarazo se usa heparina de bajo peso molecular. Si solo tiene anticuerpos sin clínica, no se trata.